Algoritmo CIF — Rodilla

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Rodilla. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 1 si «SÍ»

1b ¿Algún criterio de Ottawa (≥55 años · cabeza del peroné · rótula aislada · no flexiona 90° · no cargó cuatro pasos ni tras la lesión ni en la consulta)? Y en toda rodilla traumática con dolor anterior, elevación de la pierna extendida. Alternativa a Ottawa: Pittsburgh — contusión o caída MÁS (<12 o >50 años, o no puede caminar); S ≈99 % con E ≈60 %, pide menos radiografías (Seaberg y Jackson 1994; Seaberg 1998).

- **OTTAWA POSITIVO** → 11 Fracturas (Rótula o Meseta Tibial)
- **NO ELEVA LA PIERNA EXTENDIDA** → sin hipótesis
- **NINGUNO** → sin hipótesis

SÍ

1 ¿Hubo un evento lesivo reciente con inflamación inmediata? Rodilla aguda traumática: ¿qué mecanismo cuenta?

NO

- **SÍ** — Sensación de "pop", derrame articular rápido e inestabilidad (posible LCA) → 4 Lesión del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) → desvío 1b
- **SÍ** — Trauma rotacional con síntomas de bloqueo o chasquidos (posible Menisco) → 2 Lesión Meniscal → desvío 1b
- **SÍ** — Valgo con el pie fijo → LCM (mirar LCA y menisco medial) → 8 Lesión del Ligamento Colateral Medial (LCM) → desvío 1b
- **SÍ** — Golpe en tibia anterior con rodilla flexionada (salpicadero) → LCP y EPL → 9 Lesión del Ligamento Cruzado Posterior (LCP) → desvío 1b
- **SÍ** — Golpe anteromedial o varo cerca de la extensión → LLE y EPL → 10 Lesión del Ligamento Lateral Externo y Esquina Posterolateral (LLE y EPL) → desvío 1b
- **SÍ** — La rótula «se salió», aprensión al trasladarla lateralmente → INESTABILIDAD ROTULIANA → 12 Inestabilidad Rotuliana → desvío 1b
- **SÍ** — Golpe directo anterior, dolor con extensión resistida, escalón palpable → FRACTURA → 11 Fracturas (Rótula o Meseta Tibial) → desvío 1b
- **NO** — Dolor de inicio insidioso o crónico → sin hipótesis

2 ¿El paciente es mayor de 45 años con rigidez matutina breve (<30 min)?

- **SÍ** — Edad ≥45 años, dolor relacionado con actividad, rigidez <30 minutos → 1 Artrosis de Rodilla
- **NO** — Perfil más joven o sin patrón degenerativo → sin hipótesis

todas

2b ¿Niño o adolescente con dolor de rodilla sin mecanismo conocido? → EXPLORAR PRIMERO LA CADERA (epifisiólisis, Perthes). Solo si el cribado es normal, seguir en la rodilla.

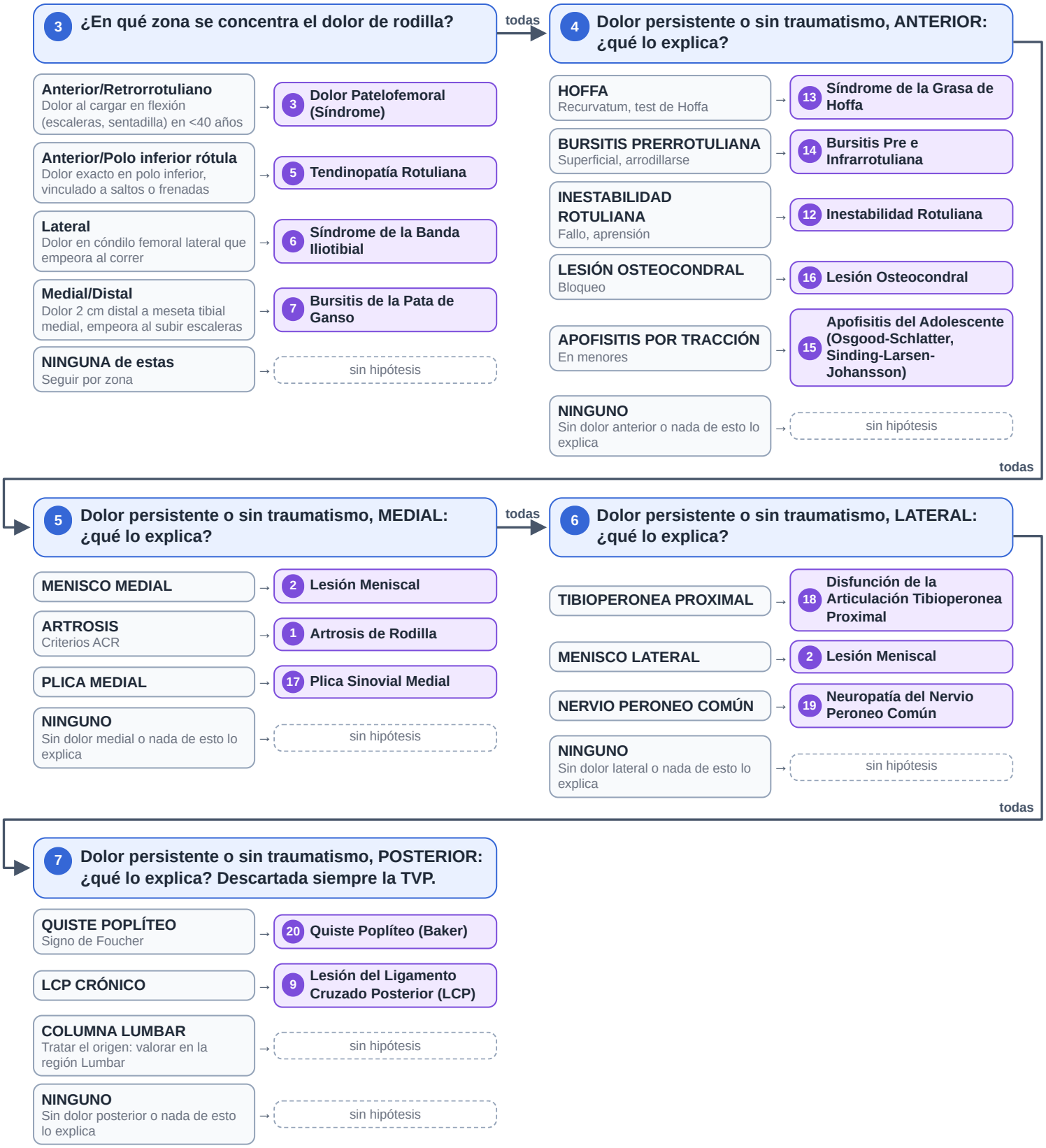
todas

- **SÍ** — Cribado de cadera alterado: derivar (epifisiólisis, Perthes) → sin hipótesis
- **SÍ** — Cribado de cadera normal: seguir en la rodilla → sin hipótesis
- **NO** — Adulto, o hay mecanismo conocido → sin hipótesis

2c ¿Reproduce el dolor de rodilla la exploración de la cadera o de la columna lumbar?

- **CADERA (artrosis)** — Tratar el origen: valorar en la región Cadera → sin hipótesis
- **COLUMNA LUMBAR (radiculopatía o pseudorradiculopatía)** — Tratar el origen: valorar en la región Lumbar → sin hipótesis
- **NO** — Ninguna de las dos reproduce el dolor de rodilla → sin hipótesis

continúa en la página siguiente →



Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor rodilla inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.